

**МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ
ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ
В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ**

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

- Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.
- Проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізу, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 годин з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.
- Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
- Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:
 - розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;
 - біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
- загальний аналіз сечі;
- інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
- Проведення інструментальних досліджень, зокрема:
 - КТ або МРТ (у цілодобовому режимі);
 - ЕКГ (у цілодобовому режимі);
 - УЗД з проведенням доплерографії;
 - інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
- Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.
- Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
- Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

- Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов'язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
- Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
- Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації).
- Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації.
- Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
- Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.
- Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров'я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
- Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді інсульту.
- Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).
- Розроблення та організація навчання для родини / доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов'язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.
- Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
- Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги:

- стаціонарно.

Підстави надання послуги:

- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:
 - I60 Субарахноїдальний крововилив;
 - I61 Внутрішньомозковий крововилив;
 - I62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
 - I63 Інфаркт головного мозку;
 - I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

Вимоги до організації надання послуги:

- ▶ Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду або місця проведення тромболізу, в якому може бути забезпечено

ний повноцінний первинний огляд за алгоритмом ABCD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), АТ (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.

- ▶ Наявність неврологічного / нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню).
- ▶ Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка інтенсивної терапії для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2 та з можливістю цілодобової подачі кисню).
- ▶ Наявність цілодобового доступу до нейровізуалізації за місцем надання медичних послуги.
- ▶ Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
- ▶ Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
- ▶ Забезпечення адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.
- ▶ Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.
- ▶ Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-терапевта, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста.

- ▶ Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерго-терапевта у перші 48 годин після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації.
- ▶ Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 годин після госпіталізації.
- ▶ Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
- ▶ Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров'я про наближення пацієнта/пацієнтки з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров'я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах «терапевтичного вікна».
- ▶ Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
- ▶ Організація та проведення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг, з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, щодо скорочення терміну «від дверей до голки» на етапі проведення тромболітичної терапії, використання шкал (наприклад, NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.
- ▶ Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
- ▶ Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов'язково відпрацьованим

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК

• СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ

сценарієм щодо впровадження проти-епідемічного режиму у 303 та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

- ▶ Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
- ▶ Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю 303 для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
- ▶ Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікар-

ських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

- ▶ Затверджений головним лікарем/медичним директором клінічний маршрут пацієнта/пацієнтки в медичному закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, який передбачає можливість переводу пацієнтів в інші заклади.
- ▶ Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма №003/о) з обов'язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.
- ▶ Забезпечення оцінки стану здоров'я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров'я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

- ▶ Окремий підрозділ (відділення) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, яке працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, принаймні 6 з яких обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з можливістю цілодобової подачі кисню.
- ▶ Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії (щонайменше 6 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.
- ▶ Наявність нейрохірургічного відділення з операційним блоком, де можуть проводитись відкриті нейрохірургічні втручання (трепанакція черепа, декомпресійна



краніотомія, забезпечення дренирування шлуночків мозку, видалення гематом).

- ▶ Наявність кабінету/відділення ангіографії, оснащеного ангіографом з нейроінтервенційними функціями.
- ▶ Можливість невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгострішому періоді ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріо-венозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі і проведення механічної тромбектомії/інших ендovasкулярних втручань.
- ▶ Можливість проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин після госпіталізації.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

- ▶ За місцем надання медичних послуг:
 - Лікар-невропатолог та/або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 - Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 - Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- ▶ У закладі:
 - Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за ос-

новним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

- Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

- ▶ За місцем надання медичних послуг:
 - Лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 - Лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-радіолог, який має відповідну підготовку з ендovasкулярних втручань при гострому мозковому інсульті – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
 - Сестра медична операційна – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 - Сестра медична-анестезист – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 - Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання медичних послуг).
- ▶ У закладі:
 - Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.